TÓM TẮT LÝ THUYẾT · NHI KHOA

BÀI 4 Thiếu máu trẻ em

Tóm tắt từ tài liệu Thiếu máu trẻ em.pdf (8 trang) · Giữ ý chính và số liệu cần nhớ · Ôn Luyện Nha Khoa

1. ĐẠI CƯƠNG
2. PHÂN LOẠI THEO SINH LÝ HỌC
3. PHÂN LOẠI THEO HUYẾT HỌC (MCV)
4. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN
5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

1. ĐẠI CƯƠNG

- **Định nghĩa:** giảm khối lượng huyết sắc tố (Hb) **dưới bách phân vị thứ 5** theo tuổi hoặc **dưới 2 độ lệch chuẩn**. Hậu quả: giảm khả năng vận chuyển **oxy** đến mô.

Nhóm tuổi	Ngưỡng Hb thiếu máu (g/dL)
Sơ sinh đủ tháng	< 13,5
2–5 tháng	< 9,5
6–59 tháng	**< 11,0**
5–11 tuổi	< 11,5
12–14 tuổi	< 12,0
≥ 15 tuổi	Nam < 13,0; nữ < 12,0

Tuổi	Nặng (g/L)	Vừa (g/L)	Nhẹ (g/L)
6–59 tháng	**< 70**	70 – < 100	100 – < 110
5–11 tuổi	< 80	80 – < 110	110 – < 115
12–14 tuổi	< 80	80 – < 110	110 – < 120

- **Dịch tễ:** phổ biến nhất ở **trẻ dưới 5 tuổi và phụ nữ có thai**. WHO 2011: **42,6%** trẻ dưới 5 tuổi thiếu máu; cao nhất châu Phi (62,3%), rồi Đông Nam Á (53,8%). Việt Nam: trẻ 6–59 tháng **31%**, thiếu máu nặng 0,4%.

2. PHÂN LOẠI THEO SINH LÝ HỌC

2.1. Giảm sinh tại tủy xương

- **Thiếu yếu tố tạo máu: thiếu sắt (phổ biến nhất)**, thiếu acid folic, thiếu vitamin B12, thiếu protein.
- **Giảm sản, bất sản tủy:** giảm sinh nguyên hồng cầu đơn thuần (**Diamond-Blackfan**), suy tủy bẩm sinh (**Fanconi**) hoặc mắc phải, **thâm nhiễm tủy** do bệnh ác tính; nhiễm khuẩn, suy thận mạn, thiểu năng giáp.

2.2. Tan máu

- **Tại hồng cầu, di truyền:** bệnh màng (hồng cầu hình cầu), bệnh hemoglobin (**α, β thalassemia**, HbE, HbS), thiếu enzym (**G6PD**, pyruvate kinase).
- **Ngoài hồng cầu, mắc phải:** miễn dịch (**bất đồng nhóm máu mẹ – con ABO, Rh**, tự miễn), nhiễm khuẩn (**sốt rét**, nhiễm khuẩn huyết), nhiễm độc (thuốc sốt rét, nitrit, nọc rắn, nấm độc), **cường lách**.

2.3. Chảy máu

- **Cấp:** chấn thương, vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết nội sọ, rối loạn đông máu.
- **Mạn, rỉ rả: giun móc**, loét dạ dày – tá tràng, trĩ, sa trực tràng.

3. PHÂN LOẠI THEO HUYẾT HỌC (MCV)

- **Hồng cầu nhỏ, nhược sắc: thiếu sắt**, chảy máu mạn, viêm nhiễm mạn, **thalassemia**, thiếu máu nguyên bào sắt (sideroblastic), **ngộ độc chì**.
- **Hồng cầu bình thường:** giảm sản, bất sản tủy; tủy bị thâm nhiễm (**bạch cầu cấp**); **chảy máu cấp**; một số tan máu (thiếu enzym, miễn dịch); cường lách.
- **Hồng cầu to: thiếu acid folic, vitamin B12**, thiểu năng giáp, bệnh gan, Diamond-Blackfan, loạn sinh hồng cầu.

4. TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN

4.1. Lâm sàng

- Thiếu máu biểu hiện **da xanh xao, niêm mạc nhợt**. Bệnh nặng: đánh giá sinh hiệu, khám tập trung để cấp cứu; bệnh không đe dọa: hỏi bệnh sử, khám toàn diện.

Biểu hiện lâm sàng	Hướng chẩn đoán
Thiếu máu nhanh, cấp	Chảy máu cấp, tan máu cấp
Sơ sinh chảy máu rốn kéo dài, phân đen, triệu chứng thần kinh	Xuất huyết, **giảm prothrombin**
Sơ sinh vàng da sẫm, li bì, co cứng	Tan máu do **bất đồng nhóm máu mẹ – con**
Trẻ nhỏ thiếu sữa mẹ, sinh non, nhẹ cân, thiếu dinh dưỡng	**Thiếu sắt**, thiếu B12, folic
Thiếu máu từ từ, đau bụng, phân đen	Xuất huyết tiêu hóa, **giun móc**
Thiếu máu, **vàng da, lách to, nước tiểu sẫm**	Tan huyết mạn (**thalassemia**)
Thiếu máu nặng kéo dài, xuất huyết, nhiễm trùng thường xuyên	**Suy tủy**
Thiếu máu, xuất huyết, **dị tật ngón cái, vết cà phê sữa**	Suy tủy bẩm sinh **Fanconi**
Thiếu máu nặng, xuất huyết, **đau xương, sốt kéo dài, hạch to**	**Bạch cầu cấp**

- **Tuổi:** sơ sinh: xuất huyết, bất đồng nhóm máu, tan máu di truyền; **3–6 tháng: thiếu máu dinh dưỡng, thiếu sắt**; > 5 tuổi: nhiễm trùng mạn, giun sán, xuất huyết rỉ rả.
- **Giới (liên kết NST X): thiếu G6PD, Hemophilia**. **Dân tộc:** bệnh hemoglobin (thalassemia, HbE), vùng sốt rét. **Tiền sử gia đình:** Hemophilia, thalassemia, thiếu G6PD.

4.2. Xét nghiệm cơ bản

- **Tổng phân tích tế bào máu:** Hb > 9 g/dL thiếu máu nhẹ; Hb < 8–9 g/dL thiếu máu rõ (da xanh, niêm nhạt). **MCV** người lớn 80–100 fL; trẻ em theo tuổi (ngưỡng dưới khoảng **70 fL lúc 6 tháng – 2 tuổi**, 73 fL lúc 2–4 tuổi, 75 fL lúc 5–7 tuổi).
- **RDW** bình thường **11,5–14,5%**; thiếu sắt: **MCV thấp, RDW tăng**; RDW tăng mà MCV bình thường gợi ý **hai quần thể** (thiếu sắt kèm thiếu B12 hoặc folic).
- **Hồng cầu lưới:** bình thường **1–2%** (50–100 K/µL); **HCL hiệu chỉnh = HCL × Hb / Hb bình thường theo tuổi**; HCL hiệu chỉnh > 2% hay > 100 K/µL: tủy **đáp ứng tăng** (mất máu, tan máu).

- **Phết máu ngoại biên:** mảnh vỡ hồng cầu (tan máu), **hồng cầu hình bia (thalassemia)**, hồng cầu nhỏ nhược sắc (thiếu sắt), hồng cầu to (thiếu B12, folic).

4.3. Xét nghiệm chuyên biệt

- **Sắt: ferritin giảm khi < 20 ng/mL (trẻ em)**, < 30 ng/mL (người lớn); sắt huyết thanh < 100 µg%; transferrin tăng > 350 µg/100 mL. Dùng phân biệt thiếu sắt với **quá tải sắt (thalassemia)**.
- **Tan máu: bilirubin gián tiếp tăng** trong tan máu ngoại mạch (thalassemia, miễn dịch); **LDH tăng** trong tan máu nội mạch (G6PD, bất đồng nhóm máu); urobilinogen niệu tăng (ngoại mạch), **hemoglobin niệu** (nội mạch).
- **Điện di hemoglobin:** HbE, HbS, α và β thalassemia. Chuyên sâu: tủy đồ, sinh thiết tủy, di truyền phân tử.

4.4. Sơ đồ tiếp cận theo MCV

- Có tổn thương **các dòng tế bào khác** → nghĩ **nguyên nhân từ tủy xương**.
- **MCV thấp:** thiếu sắt, thalassemia, thiếu máu nguyên bào sắt, bệnh mạn → khai thác dinh dưỡng, **điều trị thử bằng sắt**, ferritin, điện di Hb.
- **MCV bình thường:** HCL **≤ 3%** → nhiễm trùng, thuốc, ngộ độc chì, mất máu cấp, bệnh thận; HCL **> 3%** có bằng chứng tan máu → **thiếu máu tán huyết**; không tan máu → **xuất huyết**.
- **MCV cao:** HCL < 100 K/µL → tủy nguyên bào khổng lồ (**thiếu B12, folic**), loạn sản (MDS, Down), không nguyên bào khổng lồ (suy giáp, bệnh gan, suy tủy); HCL > 100 K/µL → mất máu, tan máu miễn dịch.

5. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

- **Phát hiện sớm:** kiểm tra dấu thiếu máu và dinh dưỡng mọi trẻ dưới 5 tuổi; AAP khuyến cáo **sàng lọc thiếu sắt cho trẻ 9–18 tháng**.
- **Điều trị bệnh nền:** chế độ ăn cân đối theo tuổi; **xổ giun định kỳ (trên 1 tuổi)**.
- **Phòng cho mẹ: viên sắt và acid folic** cuối thai kỳ; ăn giàu sắt và vitamin C.
- **Thiếu máu nhẹ và trung bình:** đánh giá chế độ ăn; **sắt nguyên tố 3 mg/kg/ngày trong 15 ngày**; xổ giun nếu 6 tháng qua chưa xổ; **tái khám sau 15 ngày**; nếu đáp ứng thì **tiếp tục 3 tháng** để phục hồi dự trữ sắt.
- **AAP:** trẻ **sinh non** bổ sung sắt từ **2 tuần tuổi**, **2–3 mg/kg/ngày**; trẻ đủ tháng **bú mẹ hoàn toàn** bổ sung sắt **1 mg/kg/ngày trước 4 tháng tuổi**.

Bản tóm tắt dùng để ôn tập nhanh, không thay thế tài liệu gốc. Đối chiếu Thiếu máu trẻ em.pdf khi cần chi tiết.